

## ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ

**Γενικά:** Τα ΤΚΑ επιτελούν αποκλεισμό των διαύλων Νατρίου στο μυοκάρδιο και τα νευρικά κύτταρα με συνέπεια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, της μυοκαρδιακής συσπαστικότητας και της νευροδιαβίβασης. Στην κατηγορία των Αποκλειστών των διαύλων Νατρίου ανήκουν επίσης η Βεραπαμίλη, η Διλτιαζέμη, η Φλεκαϊνίδη, η Προπαφαινόνη, η Κοκαΐνη κ.λπ.

Η μέση θανατηφόρα δόση ανέρχεται στα 35 mg/kg ΒΣ. Ενώ ο θάνατος είναι πολύ πιθανός σε δόσεις > 50 mg/kg ΒΣ. Παθογενετικά, ο θάνατος μπορεί να προέλθει από σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες (κοιλιακή μαρμαρυγή, παράταση QRS, ασυστολία), καταστολή του ΚΝΣ / κώμα, παρατεινόμενους σπασμούς ανθεκτικούς στη θεραπεία, αναπνευστική παύση (arrest).

**Ιστορικό:** Εξετάζουμε για την ύπαρξη μονοπολικής ή διπολικής διαταραχής. Ελέγχουμε αν το φάρμακο της τοξίκωσης (Minitran, Trittico, Stelminal, Ludiomil, Anafranil, Sinequan κ.ά.) ήταν στο «σχήμα θεραπείας» του ασθενούς. Συχνά, ο ασθενής είναι μη συνεργάσιμος.

**Κλινική εικόνα:** Ο ασθενής μπορεί να προσέλθει στο ΤΕΠ με **αντιχολινεργικά συμπτώματα** όπως: ταχυκαρδία, ξηροστομία, διαταραχές της όρασης με μυδρίαση (ή και χωρίς μεταβολές του μεγέθους της κόρης), ταχύπνοια, υπερπυρεξία, επιγαστρική δυσφορία, δυσκοιλιότητα και κατακράτηση ούρων. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί αστάθεια στη βάδιση, κόπωση, τρόμος, χορεία, αρρυθμίες, καταστολή της αναπνοής, υπόταση έως κυκλοφορικό collapsus, κώμα.

Προσοχή απαιτείται, ειδικά επί διαταραχών της καρδιακής λειτουργίας. Εφαρμόζεται συνεχές monitoring ΗΚΓ, ΑΠ, RR και SpO<sub>2</sub>. Τακτικός έλεγχος της νευρολογικής λειτουργίας (GCS).

### Θεραπευτική παρέμβαση

1. Αξιολογούμε τον αλγόριθμο A-B-C-D-E, ειδικά σε ληθαργικό ή κωματώδη ασθενή. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία [αιμοδυναμικά (ΗΚΓ, HR, ΑΠ), αναπνευστικά (RR, SpO<sub>2</sub>)], τη Θ °C, το επίπεδο συνείδησης με την GCS ή AVPU και μετράμε το επίπεδο γλυκόζης.
2. Βασικό μέλημά μας είναι η αναπνευστική υποστήριξη του ασθενούς, γι' αυτό χορηγούμε οξυγόνο σε ροή 6-12 lt/min, με απλή προσωπίδα ή με χρήση μάσκας Venturi (28-40%).
3. Τοποθετούμε ευρεία 3-way ενδοφλέβια γραμμή, με ορό 500-1000 ml NaCl 0,9%.
4. Δεν πρέπει να χορηγούμε Ιπεκακουάνα ή να προκαλέσουμε εμετό σε ασθενή κωματώδη ή ημικωματώδη ή σε ασθενή που γνωρίζουμε ότι έχει λάβει μεγάλη ποσότητα ΤΚΑ, διότι η προσπάθεια εμέτου μπορεί να οδηγήσει σε σπασμούς και πιθανότατα σε εισρόφιση. Αν η ληφθείσα ποσότητα είναι μικρή (< 5 mg/kg ΒΣ) και δεν έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 λεπτά από τη λήψη, τότε μπορούμε να χορηγήσουμε 2 fl. syr. Ipecacvom per os, για την πρόκληση εμέτου και μόνον εφόσον ο ασθενής διατηρεί καλό επίπεδο συνείδησης.
5. Εκτελούμε **έκπλυση στομάχου**, μέσω ρινογαστρικού καθετήρα Levin, μόνον εφόσον δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από 2-4 ώρες από τη λήψη της ΤΚΑ τοξικής ουσίας.
6. Εν συνεχεία, χορηγούμε **ενεργό άνθρακα** (Toxicarb), τόσο για την ουσία όσο και για τους μεταβολίτες της. Ο ενεργός άνθρακας χορηγείται σε πολλαπλές δόσεις για 1-2 ημέρες.
7. Η χορήγηση αλατούχου καθαρτικού (π.χ. γλυκερίνη, fleet enema) θεωρείται από πολλούς ότι βοηθά στη γρήγορη απομάκρυνση του φαρμάκου από το γαστρεντερικό σύστημα.
8. Για διόρθωση της υπότασης και την αιμοδυναμική υποστήριξη του ασθενούς, χορηγούμε διάλυμα 1000 ml NaCl 0,9% με 1-2 mg/kg ΒΣ Lidocaine (ή 3-8 ml Λιδοκαΐνη, iv-bolus), κυρίως για ανάταξη της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας που ευθύνεται για την υπόταση.
9. Χορηγούνται 100 ml **Λιττανθρακικό Νάτριο [NaHCO<sub>3</sub>] 4%**, εντός 30-45 λεπτών, γιατί δρα ευεργετικά στο μυοκάρδιο (ειδικά στις περιπτώσεις εμφάνισης ευρέων συμπλεγμάτων QRS > 100 msec, σε δεξιά στροφή του άξονα QRS ή επί εμφάνισης κοιλιακών αρρυθμιών). Η χορήγηση NaHCO<sub>3</sub> μπορεί να επαναληφθεί μέχρι τη βελτίωση των συμπτωμάτων, την ανάταξη των αρρυθμιών ή μέχρις ότου επιτευχθεί αρτηριακό pH ≈ 7,50-7,55.
10. Επί εμφανίσεως σπασμών, χορηγούμε 1 amp. Stedon εντός 100 ml N/S, στάγδην (iv).
11. Ταχεία διακομιδή στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring, για νοσηλεία σε ΜΕΘ/ΜΑΦ.